

**HÔPITAL UNIVERSITAIRE  
FARHAT HACHED- SOUSSE  
SERVICE DE CHIRURGIE  
GÉNÉRALE**



**FACULTÉ DE MÉDECINE IBN  
ELJAZZAR - SOUSSE  
LABORATOIRE D'ANATOMIE ET  
D'ORGANOGENÈSE**



## **SUJET 41 : ICTÈRES**

### **Objectif:**

**2. Décrire l'anatomie des voies biliaires intra et extra-hépatiques et du carrefour bilio-pancréatique**

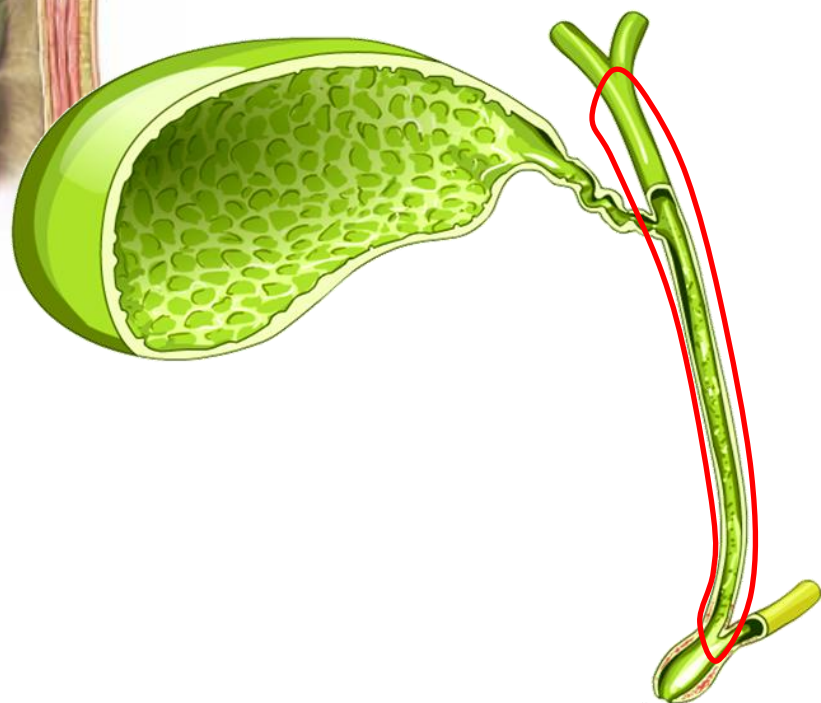
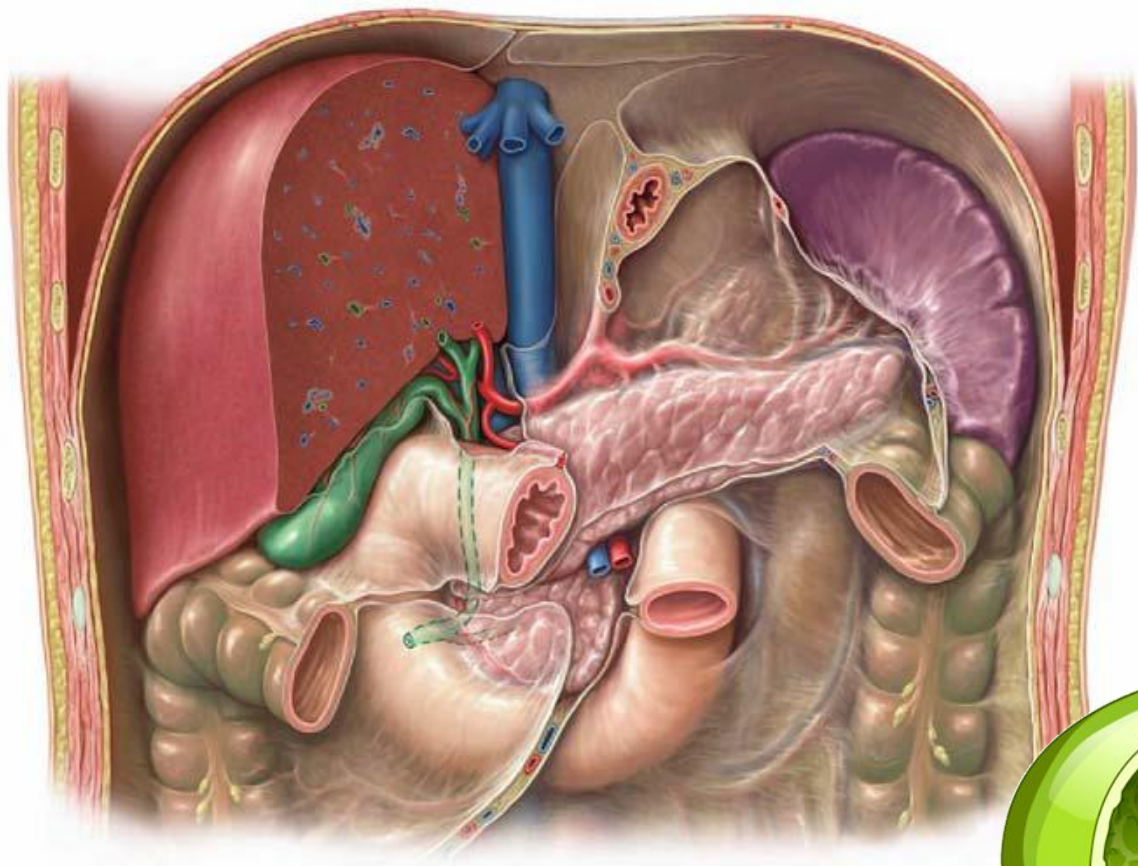
**-ÉVALUATION-**

**Professeur Mohamed Salah JARRAR**

La voie biliaire principale est représentée par :

- A- Le conduit cholédoque
- B- Toutes les voies biliaires extra-hépatiques
- C- Le conduit cystique, le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque
- D- La vésicule biliaire et le conduit cystique
- E- Le conduit hépatique commun et le conduit cholédoque

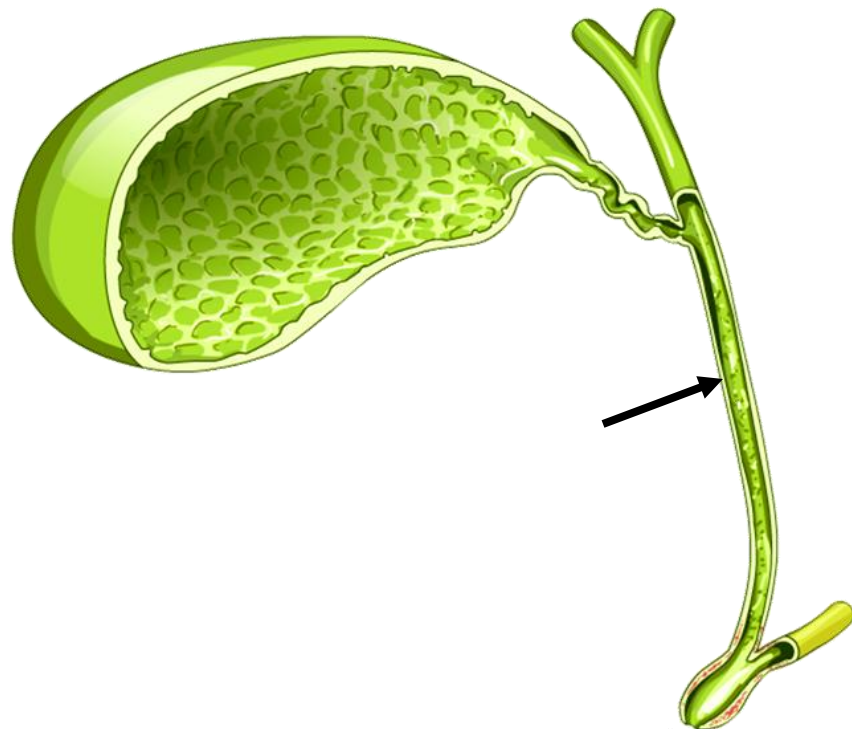
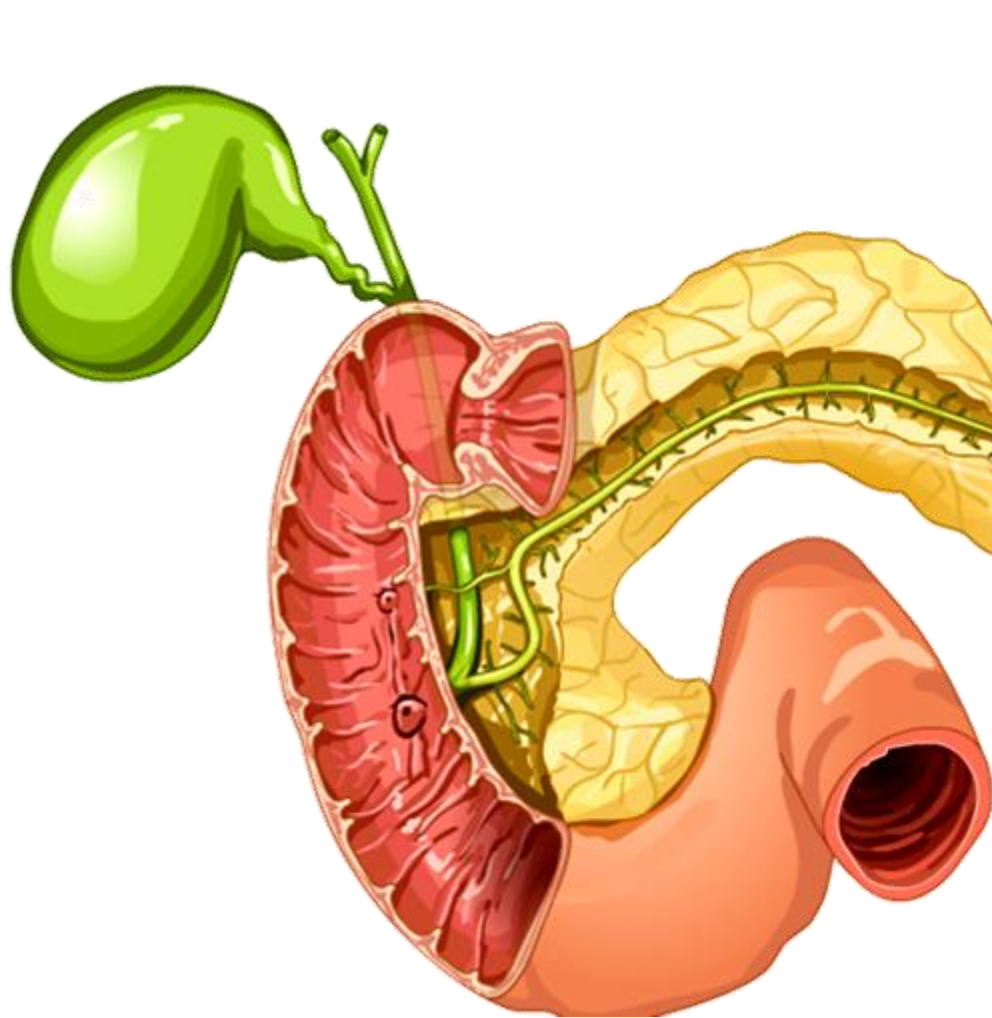
**R : E**



Le conduit cholédoque :

- A- Est la portion distale de la voie biliaire principale
- B- Reçoit le conduit cystique pour former le conduit hépatique commun
- C- Passe en arrière du deuxième duodénum
- D- Traverse l'isthme pancréatique
- E- Fusionne avec le conduit pancréatique accessoire pour former l'ampoule hépato-pancréatique

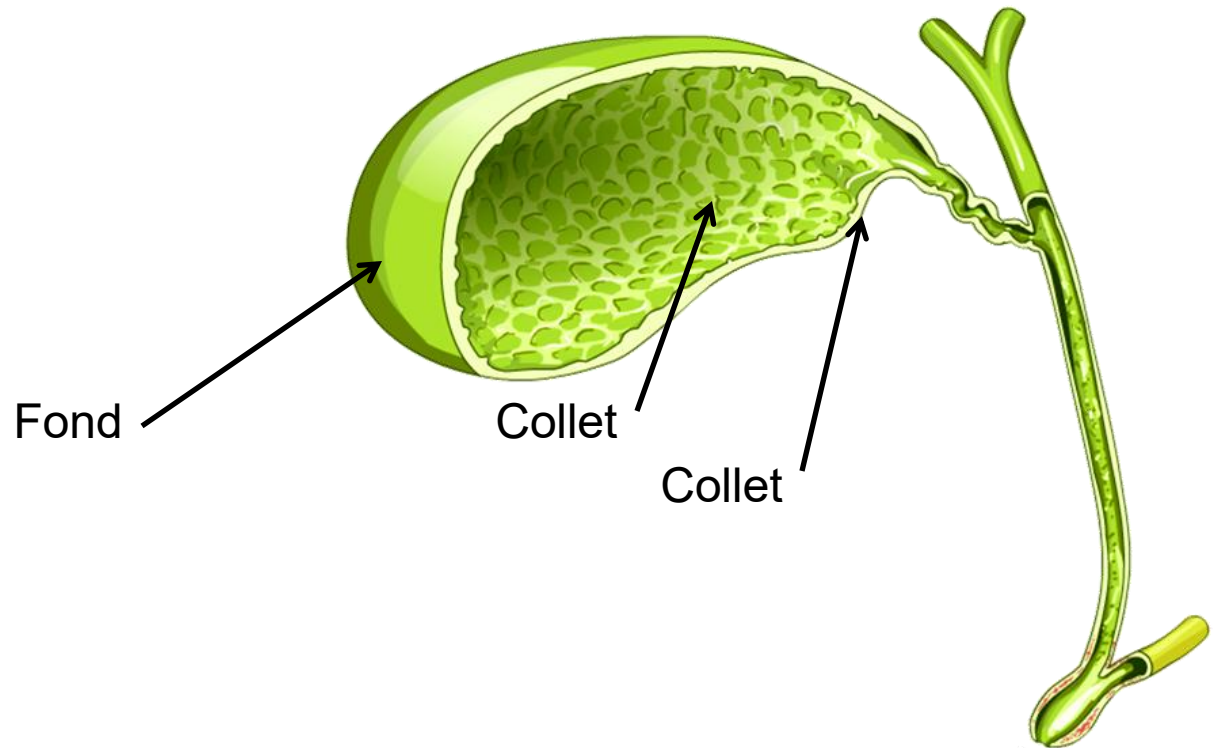
**R : A**



## La vésicule biliaire :

- A- Fait partie des voies biliaires intra-hépatiques
- B- Appartient à la voie biliaire principale
- C- S'unit, via le conduit cystique, avec le conduit hépatique commun pour former le conduit cholédoque
- D- Est située au-dessus du foie
- E- A un collet qui peut venir au contact de la paroi abdominale antérieure

**R : C**

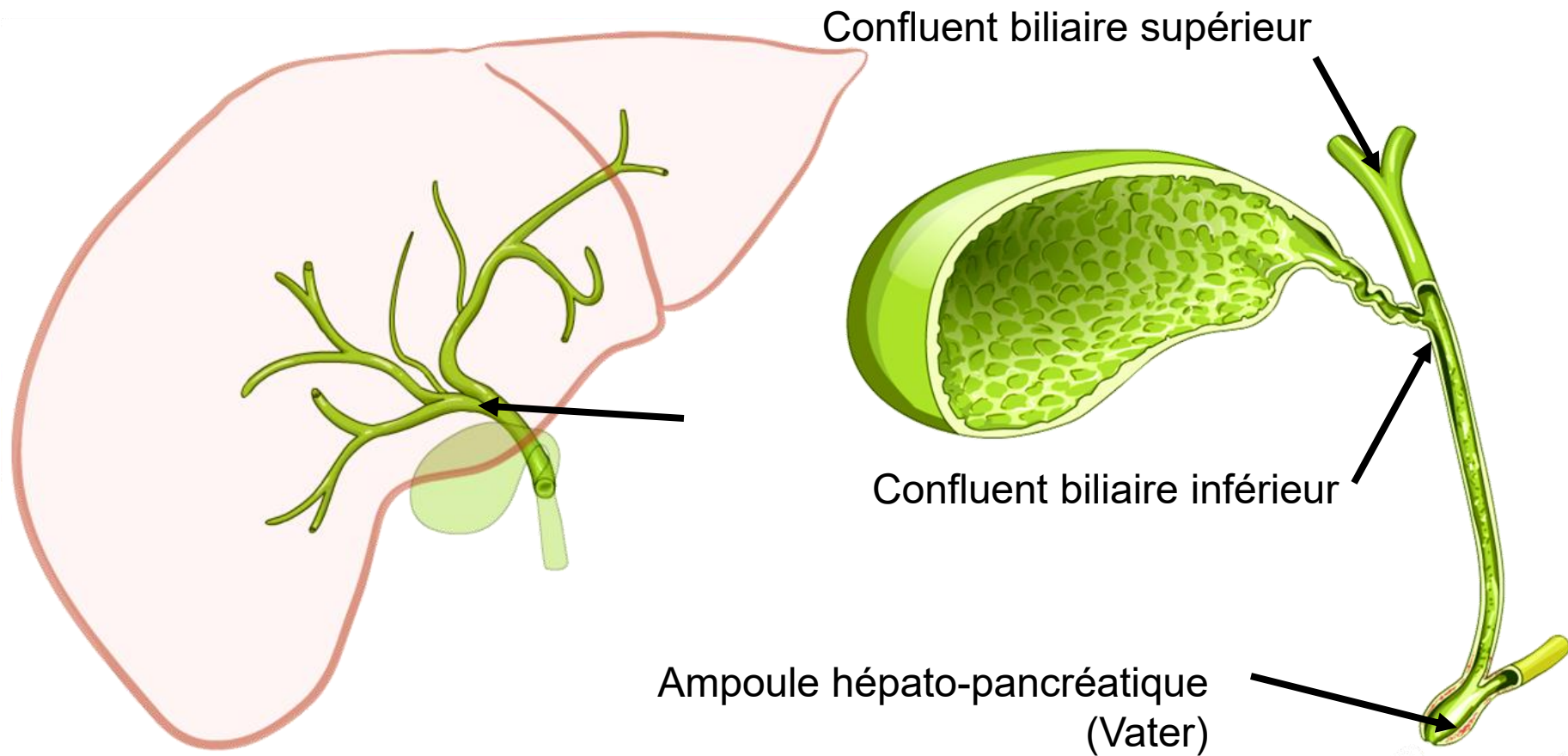




Le confluent biliaire supérieur résulte de l'union :

- A- De l'ampoule hépato-pancréatique avec le duodénum
- B- Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique principal
- C- Du conduit cholédoque avec le conduit pancréatique accessoire
- D- Des deux conduits hépatiques droit et gauche
- E- Du conduit hépatique commun avec le conduit cystique

R : D

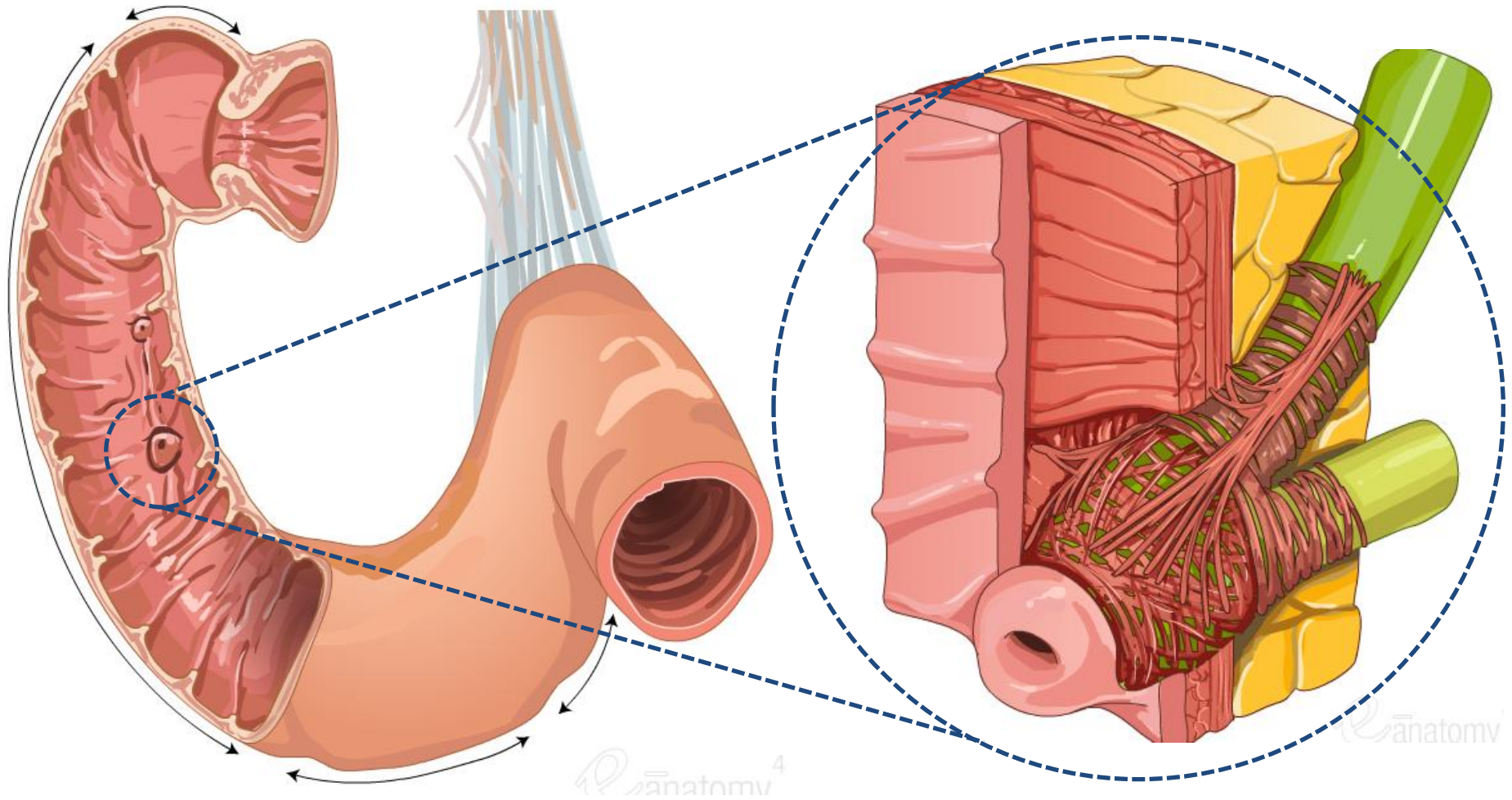


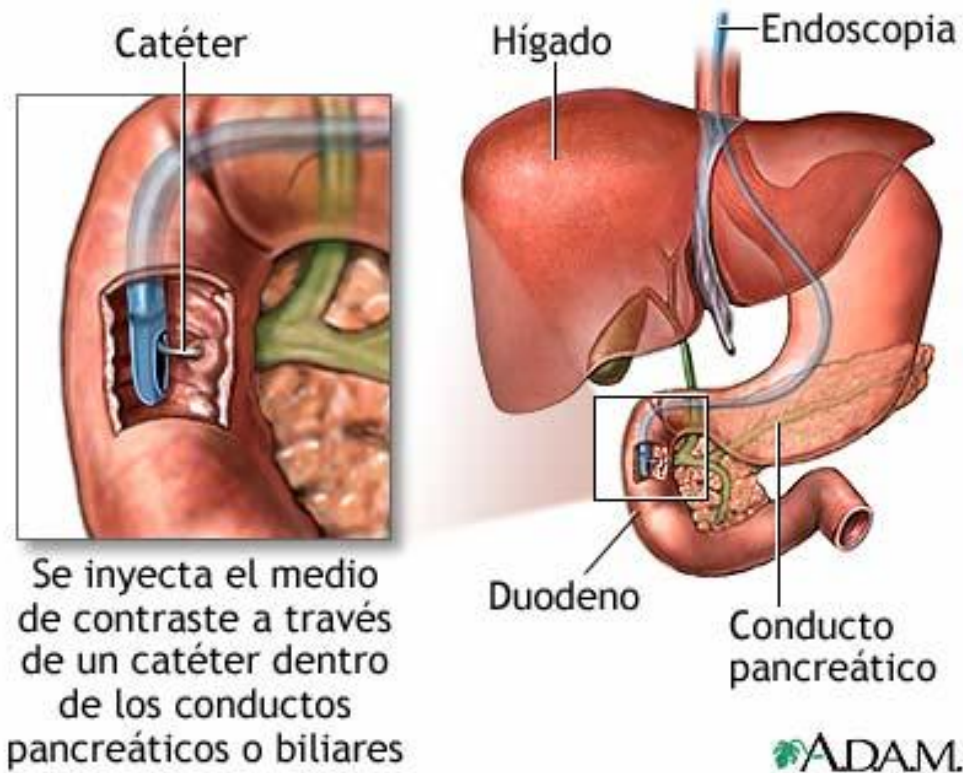


La papille duodénale majeure :

- A- Est située au-dessus de la papille duodénale mineure
- B- S'abouche dans le tiers moyen du premier duodénum
- C- Représente un abouchement commun à la voie biliaire principale et au conduit pancréatique accessoire
- D- Est facilement repérable par un endoscope à vision axiale
- E- Peut être cathétérisée pour explorer les voies biliaires et le conduit pancréatique principal

**R : E**



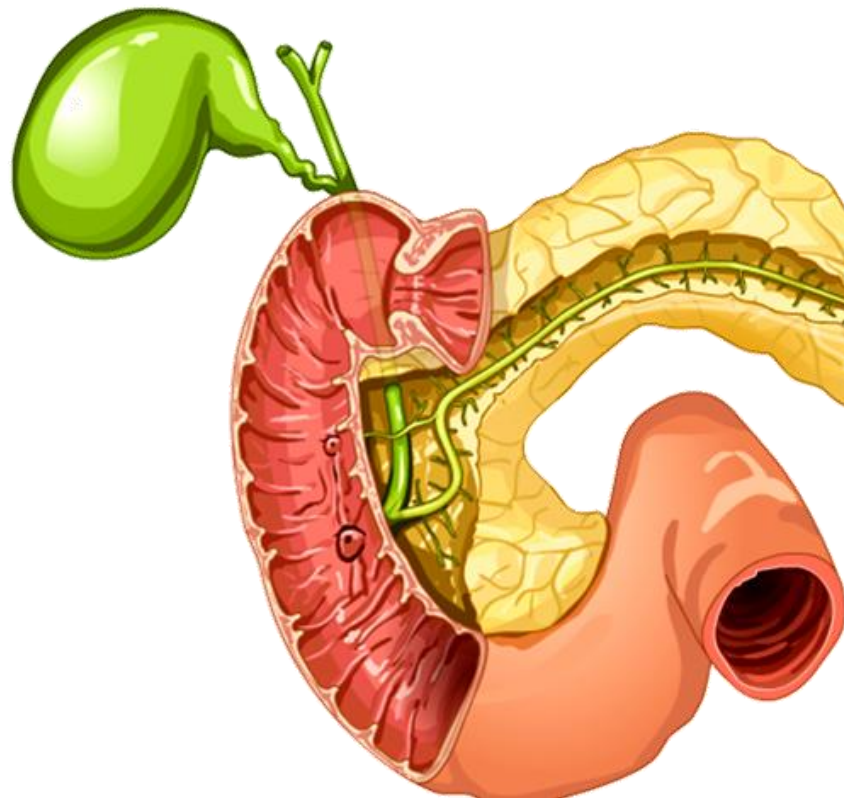


## **Cathétérisme endoscopique bilio-pancréatique: Cholangio-Pancréatographie Rétrograde Endoscopique (CPRE)**

Quel est l'élément qui n'a pas de rapports avec le conduit cholédoque ?

- A- L'isthme du pancréas
- B- La face postérieure du premier duodénum
- C- La face médiale (gauche) du deuxième duodénum
- D- La tête du pancréas
- E- Le collet de la vésicule biliaire

R : A

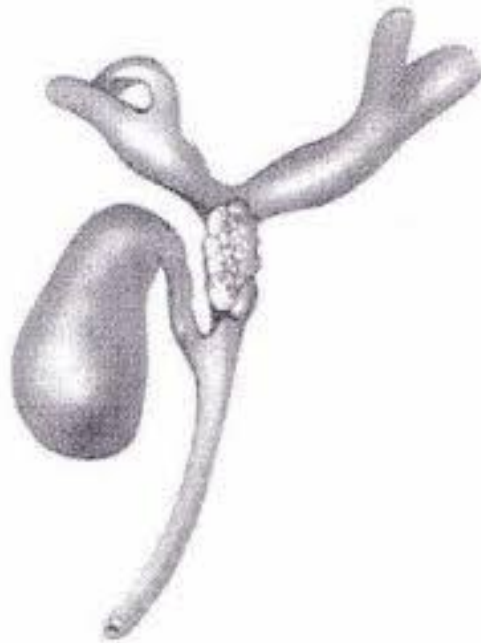




Le confluent biliaire supérieur :

- A- Est situé dans le hile hépatique
- B- Résulte de l'union du conduit cystique avec le conduit cholédoque
- C- Donne naissance au conduit cholédoque
- D- Est situé en arrière de la branche portale droite
- E- Est à l'origine d'une dilatation des voies biliaires intra et extra-hépatiques quand il est obstrué

**R : A**

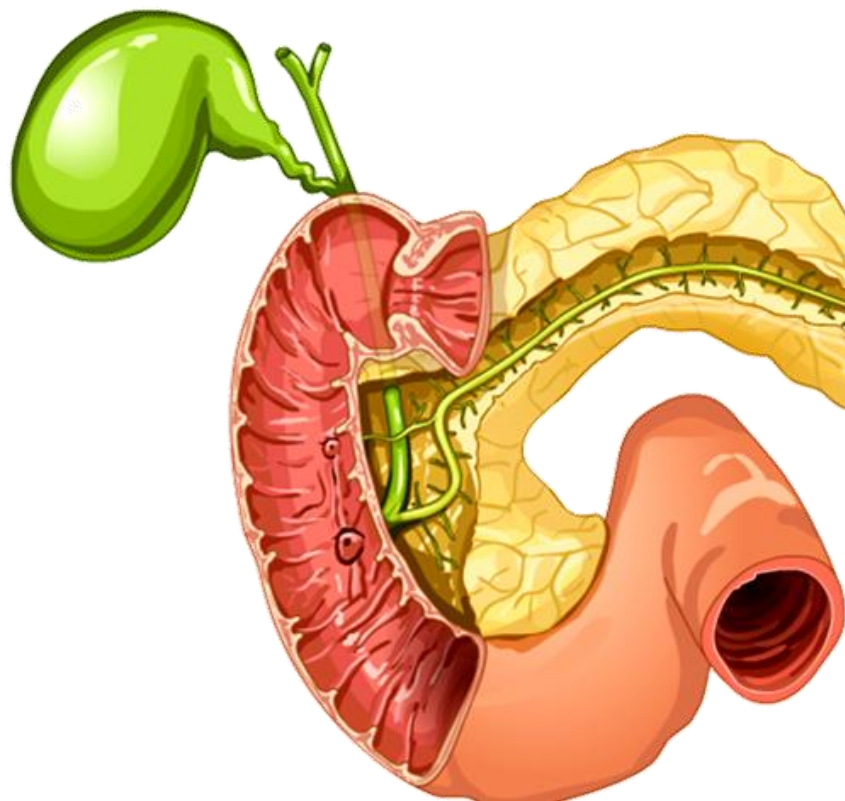


Le carrefour bilio-pancréatique :

- A- Est muni d'un seul sphincter
- B- Est situé dans l'isthme pancréatique
- C- Représente un abouchement commun de la voie biliaire principale et du conduit pancréatique principal
- D- S'abouche dans le tiers moyen de la paroi droite du deuxième duodénum
- E- N'est exploitable que par la bili-pancréato-IRM

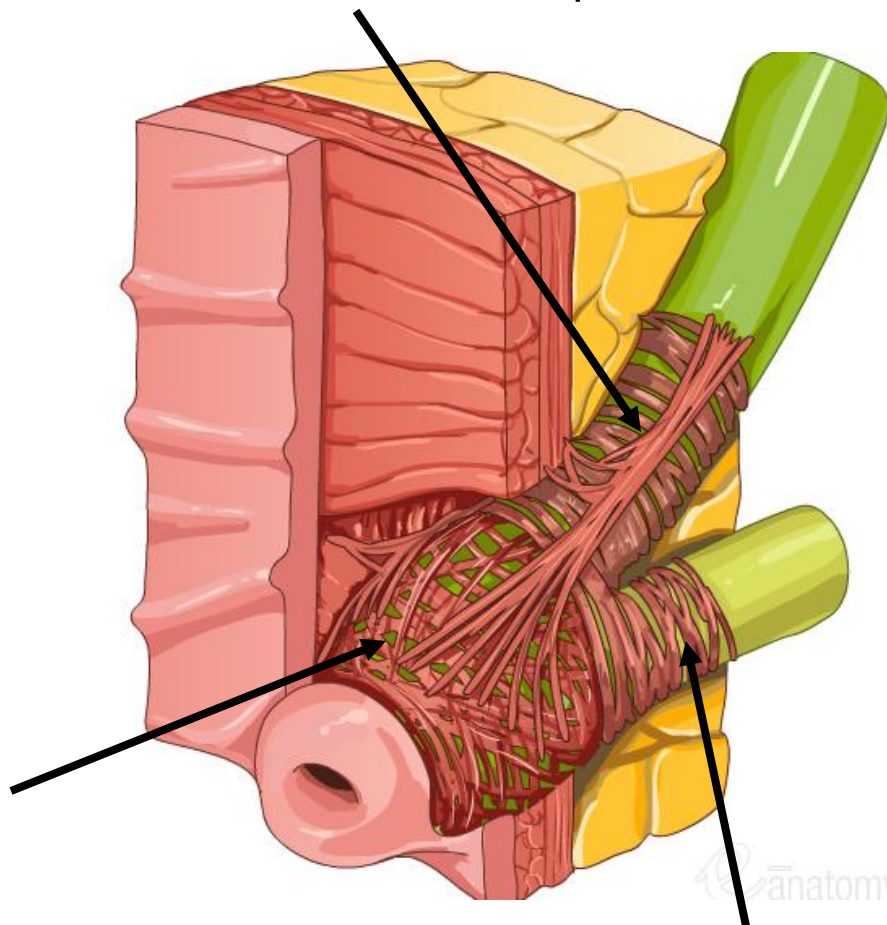
**R : C**





Sphincter hépato-pancréatique

Sphincter du conduit cholédoque

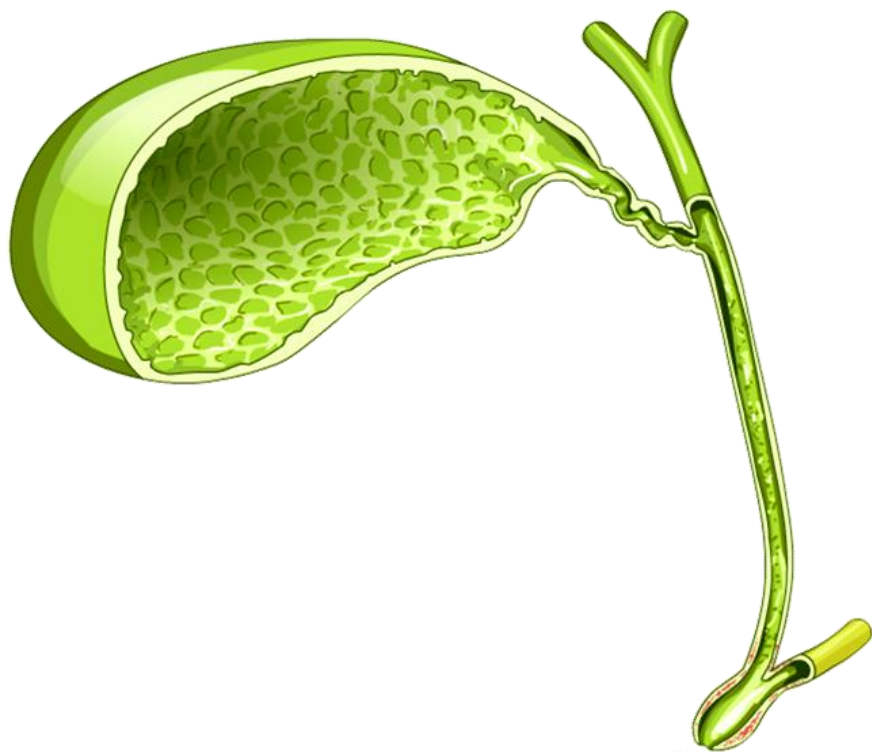
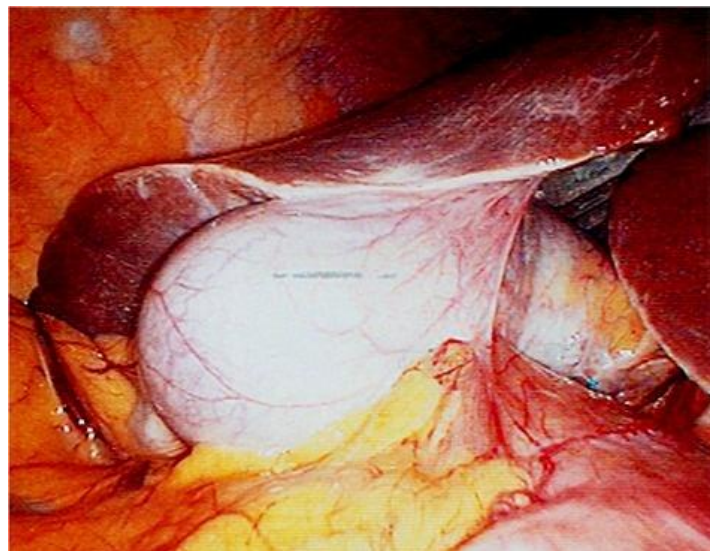


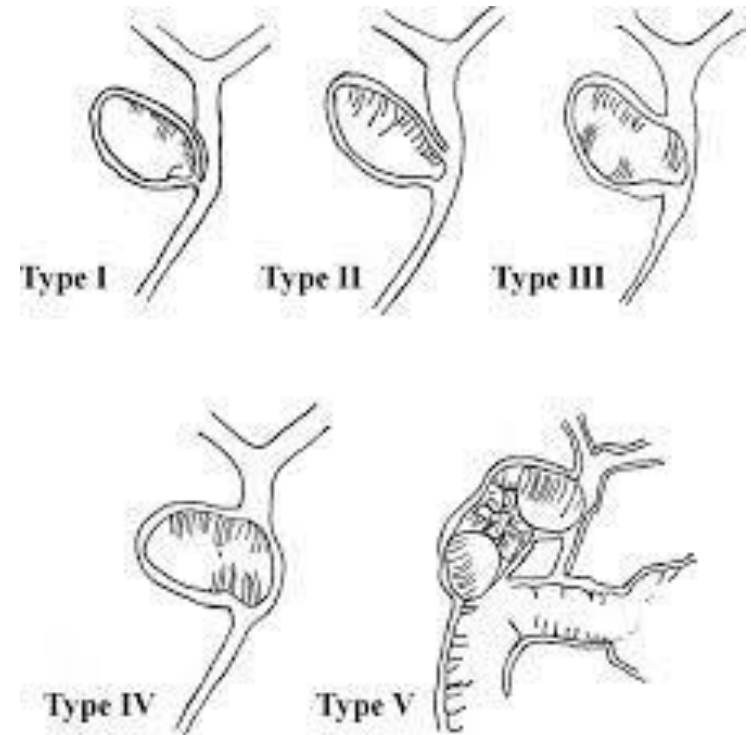
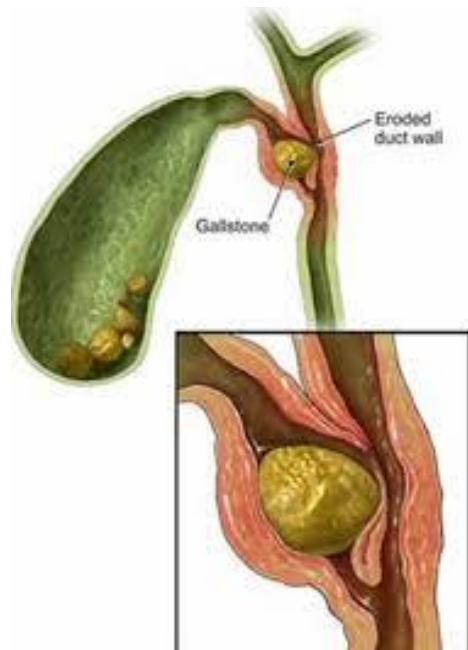
Sphincter du conduit pancréatique

## La vésicule biliaire :

- A- Est située au-dessus du foie
- B- Présente un collet en rapport avec la voie biliaire principale
- C- A un fond profond, dirigé vers l'arrière
- D- S'abouche dans le deuxième duodénum à travers le conduit cystique
- E- Est distendue en cas d'obstacle biliaire intra-hépatique

R : B





## Syndrom de Mirizzi

Un obstacle en aval du confluent biliaire inférieur et on amont du carrefour bilio-pancréatique est à l'origine d'une dilatation :

- A- Des voies biliaires intra-hépatiques uniquement
- B- De la voie biliaire principale uniquement
- C- De la voie biliaire accessoire uniquement
- D- Des voies biliaires intra et extra-hépatiques et des voies pancréatiques
- E- Des voies biliaires intra et extra-hépatiques

**R : E**



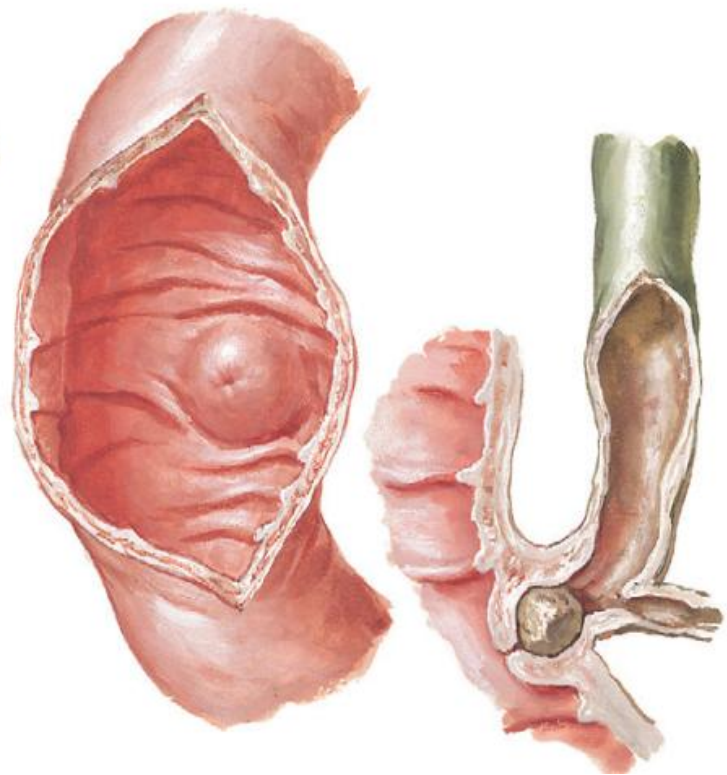
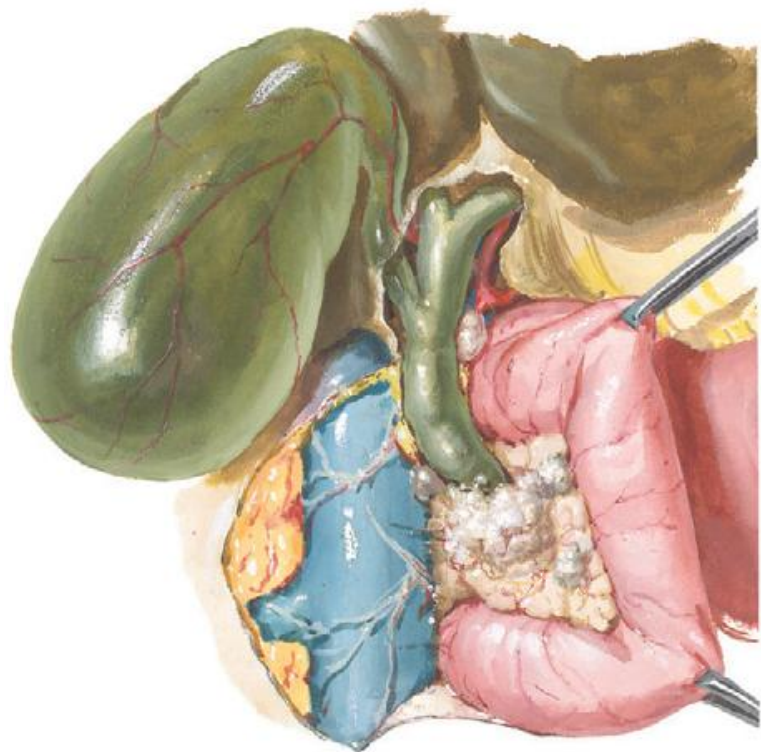
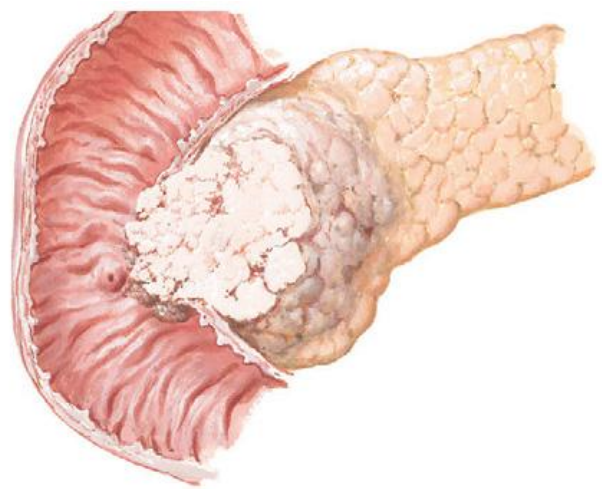


Un ictère nu avec une grosse vésicule biliaire palpable et une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatique peuvent être dû à toutes ces affections, SAUF :

- A- Un calcul enclavé du bas cholédoque
- B- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C- Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)
- D- Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
- E- Une tumeur de la tête du pancréas

**R : C**





Devant un ictère nu associé, à l'imagerie, à une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques sans dilatation des voies biliaires extra-hépatiques, on évoque :

- A- Un calcul enclavé du bas cholédoque
- B- Un cholangiocarcinome du bas cholédoque
- C- Une tumeur de Klatskin (Cholangiocarcinome hilaire)
- D- Un nodule de pancréatite chronique comprimant la voie biliaire principale
- E- Une tumeur de la tête du pancréas

**R : C**

